

CAS RÉEL · MOTEUR DE RAISONNEMENT CAUSAL

TRIPLE ACTION

Articulation de cheville modulaire pour orthèse du membre inférieur
Demandeur : Alianza Techniques d'Orthopédie (France) · Fabricant :
Becker Orthopedic (USA)

AVIS CNEDIMTS 28.01.2025 ·

SA INSUFFISANT

« Deux études de 6 et 10 patients, jamais reliées à un vrai bénéfice clinique — le moteur détecte les mêmes faiblesses méthodologiques, sans connaître l'avis de la HAS. »

01 – LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Ce que la CNEDiMTS évalue

Pour qu'un dispositif médical soit remboursé en France, la CNEDiMTS (HAS) statue sur son **Service Attendu** : la preuve clinique apportée justifie-t-elle la prise en charge ? Un avis « Insuffisant » n'est jamais arbitraire — mais les raisons précises se noient souvent dans une méthodologie dense.

Notre règle du jeu : on ne donne au moteur que les **faits de protocole** — design, population, résultats bruts. Jamais les conclusions de la HAS elles-mêmes. Le moteur détecte les mêmes signaux.

02 – LE DISPOSITIF

Une articulation de cheville pour corriger la marche

Une orthèse de cheville-pied à résistance de flexion réglable, destinée à compenser un déficit du contrôle de la marche.

« *Compensation de déficits fonctionnels de la marche pour des flexions plantaires (équin) ou dorsales (talus) excessives ou limitées, non fixées [...] rendant la marche inefficace et fatigante* »

INDICATION REVENDIQUÉE, DOSSIER CNEDIMTS

03 – L'ÉTUDE SOUMISE AU MOTEUR

Deux études biomécaniques, mêmes limites

DESIGN	Non comparative, monocentrique (USA), recueil prospectif
N	6 puis 10 patients adultes post-AVC
CRITÈRE	Cinématique et cinétique articulaire à la marche
COMPARATEUR	Aucun — alors qu'une catégorie d'orthèse comparable existe
CALCUL DU N	Non fourni

04 – SIGNAUX DÉTECTÉS PAR LE MOTEUR

Deux signaux HIGH, une structure causale circulaire

HIGH NO_COMPARATOR

Un comparateur était explicitement faisable (une catégorie d'orthèse concurrente est nommée dans le dossier) mais aucun n'a été utilisé.

HIGH Le critère évalue le dispositif... pas le patient

Le moteur classe cette situation comme un risque de circularité : les données démontrent que le dispositif fonctionne mécaniquement, mais pas qu'il apporte un bénéfice clinique.

MEDIUM Mono-centrique (gap)

Étude conduite dans un seul centre — généralisabilité non établie.

Le moteur retrouve seul les points cités par la HAS

HAS, AVIS RÉEL

« Critères de jugement
biomécaniques et non cliniques. »

MOTEUR

CIRCULARITY_RISK – HIGH

Le critère mesure le dispositif plutôt
que le bénéfice patient

HAS, AVIS RÉEL

« [...] absence de données
permettant d'apprécier l'intérêt [...] »

MOTEUR

CRITICAL

Risque global, non réparable



Alignement confirmé

06 – PROPOSITIONS DE RÉPARATION

Comment ce dossier pourrait devenir recevable

- 01 **Ajouter un comparateur** — une orthèse de la catégorie déjà citée comme concurrente.
- 02 **Chutes documentées sur 12 mois** et recours aux urgences liés (PMSI/SNDS) — critère clinique, pas biomécanique.
- 03 **Échelle de mobilité fonctionnelle standardisée** (FAC, Timed Up and Go) par évaluateur indépendant.
- 04 **Calcul du nombre de sujets nécessaires**, multicentrique.

CE QUE CE CAS MONTRE

Ce cas montre qu'un dispositif peut fonctionner parfaitement... sans démontrer qu'il améliore réellement la vie du patient.

Cas#2 d'une série sur des dossiers CNEDiMTS réels, rejoués fait par fait — sans jamais donner au moteur la conclusion de la HAS elle-même.